TEMA 37 · Desarrollo de la conducta humana. Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación. Factores socioculturales y salud. Componentes psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado. Intervención de enfermería

Resumen OPE Enfermería SMS · Kohlberg, Spitz (hospitalismo), Piaget y Erikson; personalidad (Kretschmer, Sheldon, DSM-5-TR, patrones A, B, C y D); estrés (Lazarus y Folkman, Selye), afrontamiento, Maslow, modelo transteórico; Lalonde, Dahlgren y Whitehead, Leininger; estrés por traslado, Roy, Roper y NANDA-NOC-NIC

1. Desarrollo de la conducta

- Del modelo **biomédico** (el paciente como «máquina» pasiva) al **biopsicosocial**: la respuesta a la enfermedad depende de factores psicológicos, sociales y culturales. El ingreso supone una **ruptura biográfica** (pérdida de roles y de autonomía).
- **Kohlberg (desarrollo moral)**: 3 niveles y 6 estadios:

Nivel	Estadios	En la clínica
Preconvencional (infancia, hasta ≈ 9 años)	1. Obediencia y **castigo**. 2. **Intercambio instrumental** (lo que me beneficia)	Cumple por miedo, o **a cambio de un premio o del alivio inmediato** (estadio 2)
Convencional (adolescentes y **mayoría de adultos**)	3. **Aprobación** de los demás («buen chico»). 4. **Orden social y autoridad**	Cumple para agradar o porque «es lo establecido»
Posconvencional (**minoría** de adultos)	5. **Contrato social** y derechos. 6. **Principios éticos universales**	Negocia su plan; decide con principios propios (instrucciones previas, rechazo de la obstinación)

- **René Spitz**: **hospitalismo**: deterioro físico y psíquico (retraso, infecciones, mortalidad) de lactantes institucionalizados **con buena higiene y nutrición** pero **sin afecto ni figura de apego** (la causa es la **deprivación afectiva**, no las infecciones). **Depresión anaclítica**: tras **separar** al niño de su madre con la que ya tenía vínculo (apatía, llanto, pérdida de peso, infecciones). Base de la teoría del apego de **Bowlby**.
- **Piaget (cognitivo)**: **sensoriomotor** (0-2 años: permanencia del objeto), **preoperacional** (2-7: símbolos, **egocentrismo**), **operaciones concretas** (7-11: lógica con objetos reales), **operaciones formales** (desde 11-12: **pensamiento abstracto**).
- **Erikson (psicosocial)**: **8 crisis** a lo largo de la vida; por ejemplo, **confianza/desconfianza** (lactante), **autonomía/vergüenza y duda** (1-3 años), identidad/confusión (adolescencia) e **integridad/desesperación** (vejez).

2. Personalidad

- **Biotipologías** (históricas, superadas): **Kretschmer** (pícnico, leptosomático, atlético; relacionó el cuerpo con la psicosis maniaco-depresiva o la esquizofrenia) y **Sheldon**:

Somatotipo (Sheldon)	Capa embrionaria	Temperamento
Endomorfo (redondeado)	Endodermo (vísceras)	**Viscerotónico**: sociable, relajado, amante de la comodidad y la comida
Mesomorfo (atlético)	Mesodermo (músculo)	**Somatotónico**: enérgico, competitivo, impulsivo
Ectomorfo (delgado)	Ectodermo (nervios, piel)	**Cerebrotónico**: introvertido, sensible, aprensivo

- **Trastornos de la personalidad (DSM-5-TR)**: patrones **inflexibles, persistentes y generalizados** que causan malestar o deterioro. **Grupo A** (raros: paranoide, esquizoide, esquizotípico), **grupo B** (dramáticos: **antisocial, límite**, histriónico, narcisista) y **grupo C** (ansiosos: **evitación**, dependiente, **obsesivo-compulsivo**).
- **TOC** (trastorno de ansiedad): obsesiones y compulsiones vividas con angustia (**egodistónico**). **Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad (anancástico)**: forma de ser **perfeccionista, rígida y controladora** (**egosintónica**) → en el hospital, permitir **cierto control pactado** de sus rutinas.

- **Grupo B (límite, antisocial)**: **límites firmes y uniformes** de todo el equipo (no ceder al chantaje ni dejar que enfrenten a unos profesionales con otros) y vigilar el **riesgo de autolesión**.
- **Patrones de conducta y salud**:

Patrón	Autor	Rasgos	Asociación
A	**Friedman y Rosenman** (1959)	**Competitividad, prisa, impaciencia, hostilidad**	**Cardiopatía isquémica** (la hostilidad es el componente más dañino)
B	Friedman y Rosenman	Tranquilo, paciente, disfruta del ocio	**Protector**
C	**Temoshok** (1987)	**Conformista, complaciente, suprime la ira** y las emociones negativas	**Peor evolución del cáncer** (inmunosupresión por cortisol); **no causa** el cáncer
D	**Denollet** (1995)	**Afectividad negativa + inhibición social** («sufre en silencio»)	**Más mortalidad tras el infarto**

3. Estrés, afrontamiento, motivación y hábitos

- **Lazarus y Folkman (modelo transaccional)**: hay estrés cuando la persona **valora** que las demandas **superan sus recursos**.
- **Evaluación primaria**: ¿qué significa para mí? (**daño, amenaza o desafío**).
- **Evaluación secundaria**: ¿con qué **recursos** cuento?
- **Reevaluación**: corrige según los resultados.
- **Afrontamiento**: **centrado en el problema** (actuar sobre la causa: informarse, planificar), **centrado en la emoción** (regular el malestar cuando la situación **no se puede cambiar**: relajación, reinterpretar; o desadaptativo: negación, fármacos) y **centrado en el significado** (Folkman: dar sentido, valores, espiritualidad).
- **Selye: síndrome general de adaptación** (respuesta **inespecífica** a cualquier estresor): **alarma** (simpático y **adrenalina**: taquicardia, hipertensión, midriasis) → **resistencia** (eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal: **cortisol**, hiperglucemia) → **agotamiento** (inmunosupresión, úlceras de estrés, fallo).
- **Maslow (1943)**: **fisiológicas** → **seguridad** → **afiliación** (sociales) → **estima** → **autorrealización**. Primero las básicas: **no se puede educar a un paciente con dolor intenso** (EVA 8): primero analgesia.
- **Modelo transteórico (Prochaska y DiClemente)**: **precontemplación** (no piensa cambiar en **6 meses**) → **contemplación** (ambivalencia) → **preparación** (decide hacerlo en **30 días**) → **acción** → **mantenimiento** (**> 6 meses**) → **recaída** (parte normal del proceso, sin culpabilizar).

4. Factores socioculturales

- **Informe Lalonde (Canadá, 1974)**: 4 determinantes: **biología**, **medio ambiente**, **estilo de vida** y **sistema sanitario**. Paradoja (cifras de **Dever**): el **estilo de vida** explica **≈ 43%** de la mortalidad pero recibe **≈ 1,5%** del gasto; el **sistema sanitario** explica **≈ 11%** y se lleva **≈ 90%** → justifica la **prevención y la educación para la salud**.
- **Dahlgren y Whitehead (capas de cebolla)**: **centro** (edad, sexo, genética) → **estilos de vida** → **redes sociales y comunitarias** (familia, amigos, **relaciones en el trabajo**: amortiguan el estrés) → **condiciones de vida y trabajo** (alimentación, vivienda, agua, educación, empleo, servicios sanitarios) → **condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales** generales (género, clase, etnia).
- **Madeleine Leininger (enfermería transcultural)**: teoría de la **diversidad y universalidad de los cuidados culturales**; **modelo del Sol Naciente**. Tres modos de actuar:
- **Preservación o mantenimiento** de prácticas culturales **beneficiosas**.
- **Acomodación o negociación** de las que pueden adaptarse al tratamiento.
- **Reestructuración (repatronaje)** de las **perjudiciales**, con respeto y sin **etnocentrismo**.

5. El paciente hospitalizado

- El ingreso trae **despersonalización**, horarios impuestos, miedo, falta de sueño y dolor, que agotan los recursos de afrontamiento.

- **Niños** (más aún con **TDAH**: control prefrontal inmaduro): agitación, llanto, negativa a colaborar. Evitar reprimendas; usar **juego**, **pictogramas** para anticipar y distracción.
- **Crónicos** (hemodiálisis, oncología): **conflicto de decisiones** y dificultad para integrar el tratamiento en su vida.
- **Síndrome de estrés por traslado (NANDA 00114)**: alteración física y psíquica tras un **cambio de entorno** (de casa a una residencia o entre unidades), sobre todo en **ancianos**: ansiedad, **ira**, soledad, depresión, insomnio y **confusión**. NIC **Disminución del estrés por traslado (5350)**: preparar con antelación, informar y familiarizar con el nuevo entorno.
- **Callista Roy (modelo de adaptación)**: la persona es un **sistema adaptativo**. **Estímulos**: **focal** (el que enfrenta de forma inmediata: dolor, diagnóstico), **contextuales** (los demás del entorno: **ruido**, luces, ausencia de familia) y **residuales** (creencias, experiencias previas, de efecto incierto). **4 modos de adaptación**: **fisiológico**, **autoconcepto**, **función del rol** e **interdependencia**.
- **Roper, Logan y Tierney**: valoración por **actividades de la vida**; el manual describe grados de dependencia de **0 (independiente) a 4 (dependencia total**: suplencia completa).
- **NANDA**: **afrontamiento ineficaz (00069)**, **síndrome de estrés del traslado (00114)**, gestión ineficaz de la salud, protección ineficaz, riesgo de trastorno de la imagen corporal.
- **NOC** (el **resultado** es un enunciado general con código; lo que se mide son sus **indicadores**): **aceptación del estado de salud (1300)**, **adaptación del niño a la hospitalización (1301)**, afrontamiento de problemas (1302), **conducta de cumplimiento (1601)**, sueño.
- **NIC**: **asesoramiento (5240)**, **apoyo emocional (5270)**, **potenciación de la autoestima (5400)**, **mejorar el afrontamiento (5230)**, **disminución del estrés por traslado (5350)**, **planificación del alta (7370)**, prevención de caídas (6490), protección contra las infecciones (6550).
- En el modelo de los **cinco grandes** rasgos, la **responsabilidad** predice mejor la **adherencia** y el **neuroticismo** aumenta la angustia.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Kohlberg: cumplir **a cambio de un premio** = estadio **2** (preconvencional).
! Hospitalismo de Spitz = **falta de afecto**, no infecciones.
! Piaget: egocentrismo en el **preoperacional**; abstracción en las **operaciones formales**.
! Patrón **A** → infarto; **C** → peor evolución del cáncer (no lo causa); **D** → afectividad negativa + **inhibición social**.
! TOC = egodistónico; personalidad obsesiva = **egosintónica**.
! Límite o antisocial: **límites firmes y comunes**.
! Lazarus: **primaria** = ¿amenaza?; **secundaria** = ¿recursos?
! Selye: **alarma, resistencia, agotamiento**.
! Maslow: primero lo **fisiológico** (el dolor impide aprender).
! Precontemplación **6 meses**; preparación **30 días**; mantenimiento **> 6 meses**.
! Lalonde/Dever: estilo de vida **43%** del efecto y **1,5%** del gasto; sistema sanitario **11%** y **90%**.
! Redes familiares y laborales = capa de **redes sociales y comunitarias** (Dahlgren-Whitehead).
! Leininger: **preservar, acomodar, reestructurar**.
! Roy: el **ruido** es un estímulo **contextual**; las creencias, **residuales**.